Клинические рекомендации

Острый ларингит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J04.0** — Острый ларингит **J04.2** — Острый ларинготрахеит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 01.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/309_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Главное 3

2. Клиника и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Причины 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 4

3.1 Осмотр 4

3.2 Стадии стеноза гортани 4

3.3 Ларингоскопия 5

3.4 Анализы 5

3.5 Другие исследования 6

4. Лечение 6

4.1 Режим 6

4.2 Жаропонижающие и противокашлевые 6

4.3 Местное лечение 7

4.4 Антибиотики 7

4.5 Антибиотики у взрослых 7

4.6 Антибиотики у детей 8

4.7 Лечение в стационаре 8

4.8 Другие лекарства 9

4.9 Хирургическое лечение 9

4.10 Иное лечение 10

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация **10**

5.1 Госпитализация 10

6. Источник и актуальность **10**

6.1 Неточности в самом тексте КР 11

1. Главное

- Ларингоскопия обязательна каждому пациенту. С 12 лет гортань осматривают зеркалом; если у маленького ребёнка это не удаётся, проводят видеофиброринофаринголарингоскопию.
- При неосложнённом ларингите на фоне вирусной инфекции антибиотики не назначают, пока симптомы держатся меньше 10 дней.
- При дисфонии назначают полный голосовой покой на 1–2 суток, затем ограничение голосовой нагрузки; пациент отказывается от острой, солёной, горячей и холодной пищи, алкоголя и курения.
- Флегмонозный, абсцедирующий и инфильтративный ларингит и хондроперихондрит гортани — показание к срочной госпитализации в стационар, где есть отделение интенсивной терапии и можно интубировать трахею.
- Ларингит без стеноза гортани на фоне ОРВИ госпитализации не требует; экстренно госпитализируют при дыхательной недостаточности выше I степени.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Острый ларингит (ОЛ) — острое воспаление слизистой оболочки гортани длительностью до 3 недель. Если болезнь длится дольше 3 недель, нужно исключать её аутоиммунную природу.

Абсцедирующий, или флегмонозный, ларингит — острый ларингит с образованием абсцесса, чаще на язычной поверхности надгортанника или на черпалонадгортанных складках. Он проявляется резкой болью при глотании и разговоре, отдающей в ухо, повышением температуры и плотным инфильтратом в тканях гортани. Острый хондроперихондрит гортани — острое воспаление хрящей гортани, при котором процесс захватывает надхрящницу и окружающие ткани.

Острый подскладочный ларингит (круп) — воспаление в подголосовом пространстве с отёком слизистой под голосовыми складками, затруднением дыхания и одышкой. Он встречается у детей от 6 месяцев до 6 лет.

2.2 Причины

Обычно острый ларингит — часть острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ): гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, при которых воспалены также слизистая носа и глотки, а иногда и бронхи и лёгкие. Воспаление гортани может быть и продолжением катарального воспаления носа или глотки.

Основные возбудители бактериального ларингита — S. pneumoniae (20–43%) и H. influenzae (22–35%); довольно часто высевают Moraxella catarrhalis (2–10%), разные стрептококки и стафилококки, значительно реже — Neisseria, Corynebacterium и других.

Кроме инфекции, ларингит вызывают наружная и внутренняя травма шеи и гортани, в том числе ингаляционная, инородное тело, аллергия, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и большая голосовая нагрузка. Предрасполагают к нему хронические болезни бронхов и лёгких, носа и околоносовых пазух, сахарный диабет, гипотиреоз, болезни желудочно-кишечного тракта, хроническая почечная недостаточность, нарушение разделительной функции гортани, алкоголь, курение и перенесённая лучевая терапия.

2.3 Классификация

По форме различают катаральный, отёчный, флегмонозный (инфильтративно-гнойный, в том числе инфильтративный и абсцедирующий) и острый подскладочный ларингит. По возбудителю ларингит бывает вирусным, бактериальным, грибковым и специфическим.

2.4 Клиническая картина

Основные симптомы — нарушение голоса от лёгкой дисфонии до афонии, острая боль в горле и кашель; может затрудняться дыхание и ухудшаться самочувствие. Болезнь начинается внезапно, при удовлетворительном состоянии или небольшом недомогании. При катаральном ларингите температура нормальная или субфебрильная; фебрильная температура обычно говорит о том, что воспалились нижние дыхательные пути или катаральный процесс перешёл во флегмонозный.

При инфильтративной и абсцедирующей формах сильно болит горло, трудно глотать даже жидкость, усиливается слюноотделение, голова в вынужденном положении, выражена интоксикация, нарастают признаки стеноза гортани. Чем тяжелее воспаление, тем ярче симптомы; общее состояние становится тяжёлым. Без адекватного лечения возможны флегмона шеи, медиастинит, сепсис, абсцедирующая пневмония и стеноз гортани.

Картина острого стеноза гортани одинакова при любой причине и зависит от степени сужения: дыхание становится шумным, меняется его ритм, при вдохе западают надключичные ямки и втягиваются межрёберные промежутки, пациент запрокидывает голову, гортань опускается на вдохе и поднимается на выдохе.

При неполной обструкции появляется стридор. Если преобладает отёк, дыхание свистящее, если гиперсекреция — хриплое и клокочущее. В терминальной стадии стеноза дыхание становится всё тише, потому что уменьшается дыхательный объём.

При абсцессе надгортанника на фоне острой боли сначала становится невозможно глотать, а затем, по мере прогрессирования, затрудняется дыхание. Голосовая щель может закрыться очень быстро, и тогда нужны экстренные меры для спасения жизни.

---

3. Диагностика

Диагноз ставят по анамнезу, жалобам, осмотру и ларингоскопии. Обычно болезнь начинается внезапно на фоне небольшого недомогания, пациента беспокоят изменение голоса, боль при глотании, кашель, повышенная температура. При тяжёлых формах ухудшается общее состояние, глотать больно даже жидкость, температура фебрильная, усилено слюноотделение, нарушено дыхание; шея и гортань болезненны при пальпации, подвижность хрящей гортани нарушена, голова и шея в вынужденном положении.

3.1 Осмотр

Пациента с подозрением на острый ларингит осматривает оториноларинголог, врач общей практики (семейный врач) или педиатр, чтобы поставить и уточнить диагноз.

При осмотре обязательно ищут признаки дыхательной недостаточности; главный из них — одышка. При I степени одышка возникает при физической нагрузке, при II — при малой нагрузке (неспешная ходьба, умывание, одевание), при III — в покое.

3.2 Стадии стеноза гортани

Стадия	Признаки
Компенсация	В покое одышки нет, при ходьбе появляется; просвет гортани сужен на треть.

Стадия	Признаки
Субкомпенсация	Инспираторная одышка при нагрузке с участием вспомогательных мышц, втяжение межрёберных промежутков, яремной и надключичных ямок, стридор, бледность кожи; давление нормальное или повышенное; просвет сужен наполовину и больше.
Декомпенсация	Дыхание поверхностное и частое, резкий стридор, вынужденное положение сидя, максимальные экскурсии гортани, бледно-синюшное лицо, потливость, акроцианоз, частый нитевидный пульс, давление снижено; просвет гортани щелевидный.
Асфиксия	Дыхание прерывистое или прекращается, голосовая щель резко сужена, сердечная деятельность угнетена, пульс частый, нитевидный, часто не прощупывается, кожа бледно-серая; потеря сознания, экзофтальм, непроизвольные мочеиспускание и дефекация, остановка сердца.

Если стеноз нарастает быстро, состояние тяжелее, потому что компенсаторные механизмы не успевают развиться. Это учитывают, решая вопрос об экстренной операции.

3.3 Ларингоскопия

Всем пациентам с острым ларингитом проводят ларингоскопию, чтобы осмотреть гортань.

Непрямая ларингоскопия гортанным зеркалом обязательна при осмотре пациентов 12 лет и старше оториноларингологом и в поликлинике, и в стационаре. У дошкольников и младших школьников в поликлинике она часто невозможна из-за эмоциональной лабильности и сильного глоточного рефлекса; тогда проводят видеофиброринофаринголарингоскопию.

При ларингоскопии определяют характер процесса, его локализацию, уровень, протяжённость и степень сужения дыхательных путей. Для острого ларингита типичны гиперемия и отёк слизистой гортани с усиленным сосудистым рисунком; голосовые складки розовые или ярко-красные, утолщены, голосовая щель при фонации овальная или линейная, со скоплением мокроты. Процесс может захватывать подскладковый отдел; при подскладковом ларингите видно валикообразное утолщение слизистой под голосовыми складками.

При катаральной форме изменения видны в основном на голосовых складках, в межчерпаловидном или подскладковом пространстве: расширенные поверхностные сосуды и слизистый или слизисто-гнойный секрет, усиливающий охриплость. При отёчной форме гиперемирована и отёчна вся слизистая гортани, голосовые складки смыкаются не полностью. При ларингите на фоне гриппа или ОРВИ бывают кровоизлияния в слизистую — от петехий до небольших гематом (геморрагический ларингит).

Белый или беловато-жёлтый фибринозный налёт означает переход в более тяжёлую, фибринозную форму, а серый или бурый налёт может быть признаком дифтерии. Если налёт у взрослого не связан с интубационной травмой, его нужно срочно дифференцировать с системными заболеваниями и туберкулёзом.

При инфильтративном ларингите поражённый отдел гортани значительно инфильтрирован, гиперемирован, увеличен и малоподвижен, часто видны фибринозные налёты, а там, где формируется абсцесс, просвечивает гной. При тяжёлой форме и хондроперихондрите гортань болезненна при пальпации, хрящи малоподвижны, кожа над гортанью может быть инфильтрирована и гиперемирована на фоне боли и общей гнойной инфекции. Абсцесс надгортанника выглядит как шаровидное образование на его язычной поверхности с просвечивающим гноем; он сопровождается сильной болью и нарушением глотания.

3.4 Анализы

Пациентам с острым ларингитом делают развёрнутый общий анализ крови, чтобы оценить общее состояние и выявить воспалительную реакцию — лейкоцитоз и повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ).

При флегмонозном ларингите всех пациентов при госпитализации комплексно обследуют клинически и лабораторно.

Гнойное отделяемое отправляют на посев на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы с определением возбудителя и его чувствительности к антибиотикам и другим препаратам, чтобы выбрать адекватное лечение.

При поступлении в стационар проводят стандартное лабораторное обследование.

3.5 Другие исследования

Детям младшего и дошкольного возраста проводят пульсоксиметрию, чтобы оценить степень дыхательной недостаточности и решить, нужен ли кислород.

По показаниям и для дифференциальной диагностики проводят компьютерную томографию (КТ) гортани с внутривенным болюсным контрастированием.

КТ имеет смысл в стационаре, если подозревают гнойные осложнения или трудно отличить ларингит от других болезней гортани. Если у ребёнка с признаками стеноза КТ сделать нельзя, в сомнительных случаях делают рентгенографию шеи в прямой и боковой проекциях.

---

4. Лечение

Лечение выбирают по форме и тяжести воспаления.

4.1 Режим

Всем пациентам с острым ларингитом при любой дисфонии ограничивают голосовую нагрузку — не кричать и не шептать не менее 2 дней — и назначают лечебно-охранительный режим.

При дисфонии рекомендуют полный голосовой покой на 1–2 суток, затем ограничение любой голосовой нагрузки. Пациент отказывается от острой, солёной, горячей и холодной пищи, спиртного и курения.

> Сроки голосового покоя в КР расходятся: в рекомендации — не кричать и не шептать «не менее 2-х дней», в комментарии к ней — полный голосовой покой «на 1–2 суток».

При катаральном ларингите на фоне ОРВИ пить больше обычного не рекомендуется.

Польза обильного питья сомнительна, а повышенная во время болезни секреция антидиуретического гормона, напротив, задерживает жидкость.

4.2 Жаропонижающие и противокашлевые

Взрослым и детям с фебрильной лихорадкой назначают противовоспалительные и жаропонижающие препараты.

Детям с температурой выше 39–39,5 °C, кроме лекарств, применяют физическое охлаждение: ребёнка раскрывают и обтирают водой температуры 25–30 °C.

Препарат	Доза
Парацетамол	До 60 мг/кг в сутки. Детям — 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не больше 60 мг/кг в сутки.
Ибупрофен	До 30 мг/кг в сутки. Детям — 7,5 мг/кг каждые 6–8 часов, не больше 30 мг/кг в сутки.

Детям с острым ларингитом и ларинготрахеитом противокашлевые и отхаркивающие препараты рутинно не назначают; исключение — мучительный кашель.

Прежде чем подавлять кашель, убеждаются, что нет состояний, при которых это опасно и которые требуют своего лечения, например бронхиальной обструкции, а у детей — ещё и острого обструктивного ларингита (крупа).

4.3 Местное лечение

Чтобы уменьшить воспаление слизистой гортани, назначают местную противовоспалительную терапию — вливания лекарств в гортань и ингаляции.

Для вливаний в гортань чаще всего используют антисептики из групп производных хинолина и четвертичных аммониевых соединений. Раствор подогревают до температуры тела и вливают по каплям, до 2 мл. Детям вливания в гортань не делают из-за угрозы ларингоспазма.

Применяют ингаляции через небулайзер аэрозолями средней и низкой дисперсности.

Ингаляция обычно длится 10 минут, между ингаляциями разных препаратов делают перерыв около 30 минут. Если в гортани есть корки, начинают с муколитика.

Препарат	Доза
Ацетилцистеин (раствор для инъекций и ингаляций)	Ингаляционно по 1 ампуле (3 мл) 1–2 раза в день, 5–7 дней.
#Будесонид	Ингаляционно 1000 мкг 1–2 раза в день, курс 5–8 процедур.

Можно использовать готовые аптечные смеси на основе растительных препаратов, с учётом противопоказаний и возраста — масло листьев эвкалипта прутовидного, а также 5–10% отвары цветков ромашки, листьев шалфея, травы тимьяна ползучего (чабреца), цветков календулы, листьев подорожника. Такие ингаляции бывают тёплыми и холодными; первая длится 1–2 минуты, следующие — 5–10 минут.

4.4 Антибиотики

При неосложнённом ларингите на фоне вирусной инфекции, если симптомы держатся меньше 10 дней, антибиотики не назначают.

Системные антибиотики назначают, если при неосложнённом течении симптомы сохраняются 10 дней, и при осложнённом течении.

Взрослым антибиотик целесообразен при затяжном ларингите — 10 дней и дольше, а также при выраженной инфильтрации голосовых складок и экссудации.
Взрослым антибиотик подбирают эмпирически и дают в таблетках: амоксициллин 500–1000 мг 3 раза в сутки 5–10 дней; амоксициллин с клавулановой кислотой 875/125 мг 2 раза в сутки 5–10 дней; цефиксим 400 мг 1 раз в сутки 5–10 дней; цефдиторен 400 мг 1 раз в сутки 10 дней; кларитромицин 250–500 мг 2 раза в сутки 6 дней; джозамицин 1000 мг 2 раза в сутки 5–10 дней.

4.5 Антибиотики у взрослых

Препарат	Когда	Доза внутрь
Амоксициллин	Препарат выбора	500 мг 3 раза в сутки; при факторах риска устойчивости пневмококка — 1000 мг 3 раза в сутки.
Амоксициллин + клавулановая кислота	Альтернатива; при факторах риска бета-лактамаз	500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки.
Цефиксим	Альтернатива	400 мг 1 раз в сутки.
Цефдиторен	Альтернатива	400 мг; кратность в таблице зачёркнута, в тексте — 1 раз в сутки.
Кларитромицин	Аллергия на бета-лактамы	250–500 мг 2 раза в сутки.
Джозамицин	Аллергия на бета-лактамы	1000 мг 2 раза в сутки.

Факторы риска устойчивости пневмококка к бета-лактамам — антибиотики в предшествующие 3 месяца, дети дошкольного возраста в семье, посещающие детские учреждения, проживание в «закрытых» учреждениях. Амоксициллин с клавулановой кислотой выбирают при риске возбудителя, продуцирующего бета-лактамазы (H. influenzae, S. aureus, M. catarrhalis): при бронхиальной астме, сахарном диабете, хроническом бронхите, иммуносупрессии, в возрасте старше 65 лет и при неудаче предшествующего лечения амоксициллином.

> В тексте КР цефдиторен назначают 400 мг 1 раз в сутки 10 дней, а в таблице 1 кратность у него зачёркнута целиком («2 раза в сутки 1 раз в сутки»). У джозамицина в тексте стоит код АТХ J01FA09 — тот же, что у кларитромицина, — а в таблице J01FA07.

4.6 Антибиотики у детей

В тексте КР детям предлагают амоксициллин 40–60 или 80–90 мг/кг в сутки 5–7 дней; амоксициллин с клавулановой кислотой до 3 месяцев — 30 мг/кг в сутки в 2 приёма, с 3 месяцев — 25 мг/кг в сутки в 2 приёма или 20 мг/кг в сутки в 3 приёма, 5–10 дней; цефиксим в суспензии 8 мг/кг в сутки в 1–2 приёма 5–10 дней; цефтриаксон с 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг 1 раз в сутки, а при массе больше 50 кг — взрослые дозы; кларитромицин 7,5–15 мг/кг в сутки в 2 приёма не больше 14 дней; джозамицин 50 мг/кг в сутки в 2–3 приёма 5–10 дней; тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат внутримышечно 10 дней.

Препарат	Когда	Доза
Амоксициллин	Препарат выбора	Внутрь 40–60 мг/кг в сутки; при факторах риска устойчивости пневмококка — 80–90 мг/кг в сутки.
Амоксициллин + клавулановая кислота	Альтернатива	Внутрь, суспензия 4:1 (125 мг + 31,25 мг в 5 мл или 250 мг + 62 мг в 5 мл) в 3 приёма каждые 8 часов; доза «45–60 мг/кг/сутки в 2–3 приёма» в таблице зачёркнута.
Цефиксим	Альтернатива	8 мг/кг в сутки 1 раз в сутки.
Цефтриаксон	Альтернатива	С 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг 1 раз в сутки; при массе больше 50 кг — дозы для взрослых.
Кларитромицин	Аллергия на бета-лактамы	Внутрь 7,5 мг/кг в сутки в 2 приёма, не больше 1000 мг в сутки.
Джозамицин	Аллергия на бета-лактамы	50 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат	Если нельзя ни бета-лактамы, ни макролиды	До 2 лет — по 125 мг 2 раза в сутки; 3–6 лет — по 250 мг 2 раза в сутки; 7–12 лет — по 250 мг 3 раза в сутки; взрослым — по 500 мг 2–3 раза в сутки; 10 дней.

> Детские дозы в тексте и в таблице 2 не совпадают. Кларитромицин в тексте — «для детей старше 12 лет разовая доза» 7,5–15 мг/кг/сут, в таблице — 7,5 мг/кг/сут в 2 приёма. Амоксициллин с клавулановой кислотой в тексте — 20–30 мг/кг/сут, в таблице доза 45–60 мг/кг/сут зачёркнута и указана только суспензия в 3 приёма. Цефиксим в тексте — в 1–2 приёма, в таблице — 1 раз в сутки. Для тиамфеникола возрастные группы «до 2 лет» и «от 3 до 6 лет» оставляют без дозы детей от 2 до 3 лет.

4.7 Лечение в стационаре

В стационаре антибиотики взрослым и детям назначают эмпирически с учётом региональной резистентности основных возбудителей. Когда состояние улучшится, можно перейти на приём антибиотика внутрь (ступенчатая терапия).

Препарат	Детям	Взрослым (осложнённый флегмонозный ларингит)
Амоксициллин + клавулановая кислота	С 3 месяцев внутривенно 25/5 мг/кг каждые 6–8 часов, 5–10 дней	Внутривенно 1,2 г 3 раза в сутки, 7–10 дней
Цефотаксим	Внутримышечно или внутривенно 150 мг/кг в сутки в 4 введения	Внутривенно 2 г 3 раза в сутки, 7–10 дней
Цефтриаксон	С 15 дней до 12 лет внутримышечно или внутривенно 20–80 мг/кг 1 раз в сутки, 5–10 дней	Внутримышечно или внутривенно 2 г 1 раз в сутки, 7–10 дней
Цефепим	При тяжёлом флегмонозном ларингите и осложнениях в отделении реанимации: больше 40 кг — 2 г каждые 12 часов, до 40 кг — 50 мг/кг каждые 12 часов, 7–10 дней	—
Меропенем	Там же: от 3 месяцев до 12 лет — 10–20 мг/кг 3 раза в сутки, больше 50 кг — доза для взрослых, 5–10 дней	—
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат	До 2 лет — 125 мг 2 раза в сутки, 3–6 лет — 250 мг 2 раза, 7–12 лет — 250 мг 3 раза в сутки	500 мг 2–3 раза в сутки, 10 дней

При абсцедирующем и флегмонозном ларингите всем пациентам промывают полость абсцесса антисептиками — 0,01% раствором бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммония хлорида моногидрата или гидроксиметилхиноксалиндиоксидом.

Всем пациентам с дисфагией при тяжёлых формах ларингита проводят дезинтоксикационную терапию, корректируют гиповолемию, назначают глюкокортикостероиды и парентеральное питание.

Чтобы предупредить стеноз гортани, проводят консервативную противовоспалительную терапию; для дестенозирующей терапии вводят глюкокортикоиды парентерально.

> В комментарии о дестенозирующей терапии фраза оборвана: указана доза «60–120 мг», но не названо, какого именно глюкокортикоида, и не сказано, для взрослых она или для детей.

4.8 Другие лекарства

Противогрибковые препараты эмпирически не назначают. Только после подтверждения кандидоза взрослым назначают флуконазол 100 мг в сутки или итраконазол 100 мг 1 раз в сутки на 15 дней.

Пациентам с аллергией — аллергическим ринитом, крапивницей, поллинозом, аллергическим конъюнктивитом — назначают системные антигистаминные препараты.

Препарат	Доза
Лоратадин, цетиризин	Детям 3–12 лет с массой больше 30 кг — 10 мг 1 раз в день, меньше 30 кг — 5 мг 1 раз в день; взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в день.
Левоцетиризин	Детям 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки; старше 6 лет и взрослым — 5 мг 1 раз в сутки.
Дезлоратадин	От 6 до 12 месяцев — 1 мг, с 1 года до 5 лет — 1,25 мг, 6–11 лет — 2,5 мг, взрослым и детям старше 12 лет — 5 мг; всё 1 раз в день.

> Левоцетиризину и лоратадину в КР приписан один и тот же код АТХ — R06AX13.

4.9 Хирургическое лечение

При неосложнённом остром ларингите операция не нужна.

Детям с декомпенсированным стенозом гортани для обеспечения дыхания проводят неотложную интубацию.

Если интубировать трахею невозможно, делают трахеостомию или коникотомию.

Осложнённые формы острого ларингита лечат хирургически.

4.10 Иное лечение

Пациента с острым ларингитом консультирует физиотерапевт.

При дисфонии на фоне острого ларингита КР рекомендует добавлять комплексные гомеопатические препараты, чтобы уменьшить расстройства голоса. Приведённый в КР препарат зарегистрирован по показанию «ларингиты различной этиологии» и назначается взрослым и детям старше 6 лет с первых дней болезни на 6 дней.

---

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

Пациентов голосоречевых профессий после острого ларингита наблюдает оториноларинголог до полного восстановления голоса.

Нетрудоспособность у них продлевают до полного восстановления голоса. Неосложнённый ларингит проходит за 7–14 дней, инфильтративные формы — дольше 14 дней.

Чтобы ларингит не стал хроническим, его вовремя лечат, повышают сопротивляемость организма, лечат гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и инфекции верхних и нижних дыхательных путей, отказываются от курения и соблюдают голосовой режим.

Пациенту советуют ограничить голосовую нагрузку, отказаться от горячей, холодной и острой пищи, спиртного, курения и паровых ингаляций, постоянно увлажнять воздух в помещении увлажнителем; в составе комплексного лечения КР упоминает противовирусные препараты.

> В разделе 7 и в памятке для пациента паровые ингаляции запрещены, хотя в разделе 3.1 ингаляции отваров трав допускаются «тёплыми». Там же советуют противовирусные препараты, но в разделе о лечении такой рекомендации нет.

5.1 Госпитализация

Пациенты с острым ларингитом без стеноза гортани на фоне ОРВИ в госпитализации не нуждаются. Госпитализируют всех пациентов с осложнённым течением.

Пациентов с осложнёнными и тяжёлыми формами — флегмонозным, абсцедирующим, инфильтративным ларингитом и хондроперихондритом гортани — обязательно и срочно госпитализируют в учреждение, где есть отделение интенсивной терапии и возможность интубации трахеи.

Экстренно госпитализируют при острой дыхательной недостаточности выше I степени.

Выписывают, когда воспаление идёт на убыль, дыхательной недостаточности и осложнений нет.

При неосложнённом ларингите прогноз благоприятный. При осложнённых формах со стенозом гортани жизнь пациента спасают своевременная специализированная помощь и операция.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острый ларингит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 01.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)

Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	309_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Союз педиатров России
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Сроки голосового покоя расходятся: в рекомендации — «не менее 2-х дней», в комментарии — «1–2 суток».
- Цефдиторен: в тексте — 400 мг 1 раз в сутки, в таблице 1 кратность зачёркнута целиком.
- Джозамицину в тексте приписан код АТХ J01FA09 (код кларитромицина), в таблице — J01FA07.
- Детские дозы кларитромицина, амоксициллина с клавулановой кислотой и цефиксима в тексте и в таблице 2 различаются; у кларитромицина «разовая доза» дана в мг/кг/сут и «для детей старше 12 лет».
- Для тиамфеникола глицината ацетилцистеината нет дозы для детей от 2 до 3 лет: группы «до 2 лет» и «от 3 до 6 лет».
- В комментарии о дестенозирующей терапии не назван глюкокортикоид, к которому относится доза «60–120 мг».
- Левоцетиризину и лоратадину приписан один код АТХ R06AX13.
- Раздел 7 запрещает паровые ингаляции и советует противовирусные препараты, а раздел 3.1 допускает тёплые ингаляции и не содержит рекомендации о противовирусных.
- В комментарии о меропенеме для детей авторы ссылаются на справочник Vidal.